

Consentimiento informado, asentimiento y retiro de decisión

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Documentar un proceso comprensible, específico, voluntario y previo a cada intervención que lo requiere.

2. Alcance y condiciones de uso

Consentimientos terapéuticos separados de autorización de datos e imágenes. Técnicas nuevas o riesgos diferentes requieren información y decisión actualizadas; no hay permiso global para cualquier tratamiento.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Autor de la atención	Registrar de manera oportuna, íntegra y autenticada.
Custodio	Controlar acceso, conservación, entrega y recuperación.
Apoyo administrativo	Acceder solo a datos necesarios según permiso.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Verificar identidad, capacidad de decidir y apoyos sin presumir incapacidad por discapacidad

Verificar identidad, capacidad de decidir y apoyos sin presumir incapacidad por discapacidad. En menores evaluar autonomía progresiva y riesgo conforme a Resolución 309 de 2025; representación y consentimiento sustituto cuando correspondan, sin imponer concurrencia adulta a todo adolescente.

2. Explicar motivo, técnica, región, contacto, beneficios esperados sin garantía, riesgos frecuentes

Explicar motivo, técnica, región, contacto, beneficios esperados sin garantía, riesgos frecuentes y graves relevantes, precauciones y alternativas, incluyendo no realizar o aplazar.

3. Individualizar riesgos con antecedentes y condiciones; registrar preguntas y respuestas

Individualizar riesgos con antecedentes y condiciones; registrar preguntas y respuestas. No presentar una lista genérica como información suficiente de toda técnica.

4. Comprobar comprensión con explicación del paciente y ofrecer tiempo razonable

Comprobar comprensión con explicación del paciente y ofrecer tiempo razonable. Evitar presión por pago o agenda y permitir acompañante cuando procede.

5. Registrar aceptación, rechazo, aplazamiento o retiro, fecha y hora y soporte válido

Registrar aceptación, rechazo, aplazamiento o retiro, fecha y hora y soporte válido. Los formatos sin campos de firma requieren mecanismo complementario auténtico; no simular firma ni sustituirla por un nombre digitado sin control.

6. Respetar retiro y límites durante la sesión

Respetar retiro y límites durante la sesión. Registrar intervención no realizada, consecuencias explicadas y continuidad ofrecida, sin cláusulas de exoneración o renuncia a derechos.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Información específica y antes de técnica.

Representación acreditada y apoyos documentados.

Decisión actual y autenticación válida.

Rechazo no elimina derecho a orientación o alternativas.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.6 y 11.3.1.27-28: historia y registros; Resoluciones 1995/1999, 839/2017, Ley 1581/2012 y consentimiento conforme a Ley 528/1999 y reglas particulares.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Paciente y representante si corresponde	
Técnica y región	
Beneficio esperado	
Riesgos individuales	
Alternativas	
Preguntas y respuestas	
Comprensión y apoyo	
Decisión fecha hora	
Soporte de aceptación y autorización	
Cuidados y seguimiento	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Ejercicio profesional

Ley 528 de 1999, artículos 1-3 y 27, principios, competencias y consentimiento previo. El contenido exige evaluación integral y fundamento científico; no garantiza resultados ni amplía competencias por tener un formato.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66199>

Historia clínica

Resolución 1995 de 1999, artículos 3-5 y 11-14: registro, autorización, anexos, custodia y acceso. Resolución 839 de 2017, artículo 3: retención general mínima de 15 años y reglas especiales; el archivo no se elimina automáticamente al vencer un plazo.

<https://minsalud.gov.co/ihce/Paginas/Normatividad.aspx>

Datos sensibles

Ley 1581 de 2012, artículos 4-6, 8-12 y 17-18; Decreto 1074 de 2015, reglas de tratamiento. Información de salud y finalidades opcionales requieren análisis de base jurídica, autorización cuando exigible y seguridad.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Autonomía progresiva

Resolución 309 de 2025: información, participación, autonomía progresiva y contextual, consentimiento y asentimiento de niños, niñas y adolescentes. Evaluar habilidades y riesgo; no imponer representación sustituta universal a todo adolescente.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No%20309%20de%202025.pdf

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576